

温之,瘀则化之,以益气温阳养血、活血化瘀通脉为治则。广东太安堂心宝丸宗于此则,方药组成严谨合理,经临床证实,能明显提高心率,并有效改善心慌、胸闷、畏寒、腰酸、乏力或头晕等症状。

针刺所取内关为手厥阴心包经之络穴,八脉交会穴之一,通于阴维脉,阴维之为病,令人苦心痛。公孙为足太阴脾经之络穴,八脉交会穴之一,通于冲脉,冲为血海,冲脉之为病,令人逆气脉缓。二穴相配有调中益气补心活血之效。巨阙为心之募穴,可调理心气。足三里属足阳明之脉,所入为合,有补中益气之功。神门为手少阴之脉,所注为俞,心之原穴,能补心气而活络^[4]。三阴交为足三阴经气会聚之所,益肝肾补脾气而化瘀。二穴相配有补心健脾,活络化瘀之效。

心动过缓乃心气不足,即阳气不足,阳气不足,

“以火补之”,使用艾灸,则可补益心气,促进心脏功能得到改善,心率复常。

通过临床实践观察,针灸配合广东太安堂心宝丸治疗心动过缓疗效较好,值得临床进一步研究、推广。

参考文献

- [1] 张涛,杭群. 针灸现代研究与临床 [M]. 北京: 中国医药科技出版社,1998: 85.
- [2] 胡霞,肖延华,袁学军. 针灸配合中药治疗心脏病 73 例观察 [J]. 实用中医药杂志,2010,26(1): 7.
- [3] 张华,田从豁,刘保延,等. 田从豁教授临床配穴学术思想与观点小结 [J]. 针灸临床杂志,2007,23(2): 36-38.
- [4] 何海明. 滞针法结合局部温针灸治疗筋急证 [J]. 针灸临床杂志,2003,19(1): 33.

(本文校对: 骆新生 收稿日期: 2012-06-13)

低频电刺激治疗卒中后吞咽障碍的疗效观察

李转会¹ 李 丽² 刘文蕊¹

摘要:目的 探讨低频电刺激疗法对卒中后吞咽障碍的临床疗效。方法 将 50 例急性卒中后吞咽障碍的患者随机分为低频电刺激组及对照组各 25 例。两组均接受常规药物治疗及康复训练。两组治疗前、治疗后第 1 周及治疗后第 2 周以吞咽障碍的分级评分标准评定疗效。结果 两组治疗后吞咽障碍评分均明显高于治疗前 ($P < 0.01$); 低频电刺激治疗组评分明显高于对照组 ($P < 0.01$); 低频电刺激治疗组第 1 周、第 2 周评分均高于对照组 ($P < 0.05$)。结论 低频电刺激疗法可明显改善卒中后吞咽障碍患者的临床疗效,疗程与疗效具有相关性,配合康复训练等综合治疗可提高疗效,改善患者预后。

关键词: 低频电刺激; 吞咽障碍; 卒中; 康复训练

doi: 10.3969/j.issn.1003-8914.2012.12.055

文章编号: 1003-8914(2012)-12-2485-02

吞咽障碍是各种原因所致食物从口腔到胃的过程中出现障碍的表现,是脑卒中较为常见的并发症之一。有统计显示,大脑卒中后吞咽障碍发生率为 44.7%,脑干、延髓卒中后吞咽障碍的发生率为 55%^[1],卒中后吞咽障碍可导致营养不良、卒中后肺炎、焦虑抑郁等并发症,严重影响患者生存及生活质量。国内研究^[2]认为吞咽障碍是脑卒中发生 3 个月后预后不良的独立危险因素。近年来,我科应用低频电刺激疗法结合康复训练治疗卒中后吞咽障碍取得了较好的疗效,现报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 2011 年 4 月~2012 年 4 月在我院神经内科住院的急性卒中中伴吞咽障碍的患者 50 例,其中男 31 例,女 19 例,年龄 40~79 岁,平均 68.5 岁,吞

咽障碍均为首次发生,脑梗塞 38 例,脑出血 12 例。脑梗死的诊断符合中国急性缺血性脑卒中诊治指南 2010 诊断标准,脑出血的诊断符合全国第四届脑血管疾病会议修订的诊断标准^[3]。经头颅 CT 和(或)MRI 证实为急性脑卒中。所有患者治疗前进行洼田饮水试验做吞咽功能评定。排除标准:不能配合评定者及伴有严重并发症、昏迷、严重认知及视听功能障碍者、精神疾病、无法判断疗效或资料不全影响疗效判断者。将患者随机分为低频电刺激治疗组和对照组(各 25 例),两组患者的性别、年龄、吞咽障碍康复开始时间、病情经比较差异均无统计学意义($P > 0.05$),具有可比性。

1.2 治疗方法

1.2.1 对照组 常规药物治疗(按脑卒中诊疗规范)加吞咽功能训练,包括口颊部、舌部的主动、被动活动及口腔冰棒刺激等规范的康复训练,由专业康复治疗师进行训练,20min/次,2 次/d。

作者单位:1. 陕西中医学院中西医结合脑病(西安 712046); 2. 甘肃省平凉市第二人民医院(平凉 744000)

1.2.2 低频电刺激治疗组 在常规药物治疗及吞咽功能康复训练基础上加用低频电刺激治疗,使用 Vital Stim 电刺激治疗仪。该治疗仪为双通道,输出交流、矩型对称双相波,强度为 0~25mA,可调,第一电极放置于舌骨上方,第二电极紧挨第一电极下放置,置于甲状腺上切迹上方,第三、第四电极按前两电极之间的等距离放置,沿颈前正中垂直排列所有电极。治疗时间 30 分/次,1 次/d,刺激的同时患者进行吞咽动作。

1.3 评定方法 疗效评定标准 根据洼田饮水试验分级标准^[4]进行疗效评定。患者端坐,饮 30ml 温开水,观察所需时间和呛咳情况。1 级:能顺利的 1 次饮水咽下;2 级:分 2 次以上,能不呛咳地咽下;3 级:能 1 次咽下,但有呛咳;4 级:分 2 次以上咽下,但有呛咳;5 级:频繁呛咳,不能全部咽下。正常:1 级,5 秒之内;可疑:1 级,5 秒以上或 2 级;异常:3、4、5 级。治疗后,显效为吞咽障碍消失,饮水试验评定 1 级;有效为吞咽障碍显著改善,饮水试验评定 2 级;无效为吞咽障碍无明显改善,饮水试验评定 3 级以上。

1.4 统计学方法 采用 SPSS17.0 统计软件进行分析,两组患者的疗效比较采用 Ridit 分析, $P < 0.05$ 为差异有统计学意义(表 1、表 2)。

表 1 两组治疗第 1 周末疗效比较 (n,%)

组别	例数	显效	有效	无效	有效率
对照组	25	5	5	15	40.0
电刺激组	25	9	12	4	84.0

表 2 两组治疗第 2 周末疗效比较 (n,%)

组别	例数	显效	有效	无效	有效率
对照组	25	9	7	9	64.0
电刺激组	25	15	8	2	92.0

2 结果

治疗 1 周后对照组显效 5 例,有效 5 例,无效 15 例;观察组显效 9 例,有效 12 例,无效 4 例;治疗两周后对照组显效 9 例,有效 7 例,无效 9 例;观察组显效 15 例,有效 8 例,无效 2 例;两组治疗后吞咽障碍评分均明显高于治疗前($P < 0.01$);电刺激治疗组评分明显高于对照组($P < 0.01$);电刺激治疗组第 1 周、第 2 周评分均高于对照组($P < 0.05$)。

3 讨论

电刺激疗法是利用一定强度的,通过预设的刺激程序来刺激咽部肌肉,诱发肌肉运动或模拟正常的自主运动,以达到改善或恢复被刺激肌肉或肌群功能的目的。其机制是通过电流在肌肉神经接点产生外周运

动神经的去极化,依次引起肌肉收缩,同时刺激大脑能更大程度地自身重组。研究表明,电刺激可兴奋咽喉部肌肉,防止失用性萎缩;通过刺激受损部位的神经,使其活性增加;反复刺激兴奋大脑的高级运动中枢,能帮助恢复和重建正常的反射弧,促进新传导通路的重建。由于中枢神经系统具有强大的可塑性,持续刺激可使中枢突触增强或重建,实现神经系统的重新组合^[5]。

本研究显示,经过早期评估及积极干预措施,患者吞咽能力均有不同程度的恢复,观察组疗效明显优于对照组,第 1 周有效率达 84%,第 2 周有效率达 92.0%。Leelamanit 等^[6]认为,吞咽时同步电刺激甲状舌骨肌,可通过减少喉上提幅度改善吞咽困难,同步电刺激具有非侵袭性的优点,有利于恢复正常的吞咽机制,降低鼻饲和胃造瘘术的发生率。

本研究还发现,治疗第 2 周末效果优于第 1 周末,可能由于脑血管疾病本身存在一定的自限性,同样吞咽功能也有自愈成分;组间比较低频电刺激疗法较对照组在治疗脑卒中吞咽功能障碍具有较明显疗效,因此可以说明低频电刺激疗法对吞咽功能恢复起着重要作用,由于长时间的肌肉电刺激,吞咽功能系统重建更加完善,也提示电刺激治疗疗程不应少于 2 周。

总之,低频电刺激治疗组患者在药物治疗的基础上,通过低频电刺激仪、吞咽康复训练等综合治疗,其疗效明显优于对照组,吞咽障碍症状改善迅速,且无明显不良反应,表明低频电刺激疗法结合综合康复能够促进脑卒中后吞咽障碍的恢复,能明显改善患者吞咽功能障碍,提高患者生存质量。

参考文献

- [1] Lawrence ES, Coshall C, Dundas R, et al. Estimates of the Prevalence of Acute Stroke Impairments and Disability in a Multiethnic Population. Stroke(80039-2499). 2001, 32(6): 1279-1284.
- [2] 孙伟平, 阿依古丽艾山, 王欣华, 等. 115 例急性脑卒中患者标准吞咽功能评估 [J]. 中国康复理论与实践, 2006, 12(4): 282-284.
- [3] 中华医学会神经病学分会脑血管病学组, 急性缺血性脑卒中诊治指南撰写组. 中国急性缺血性脑卒中诊治指南 2010 [S]. 中华神经科杂志, 2010, 43(2): 146-153.
- [4] 全国第 4 届脑血管病学术会议. 脑卒中患者临床神经功能缺损程度评分标准(1995) [J]. 中华神经科杂志, 1996, 29: 381.
- [5] 王拥军. 神经病学临床评定量表 [J]. 2005, 6: 217.
- [6] 郭建一, 陈泉, 胡美云, 等. 综合康复治疗脑梗死后吞咽障碍的疗效研究 [J]. 中华内科杂志, 2011, 8(14): 2602-2603.
- [7] Leelamanit V, Limsakul C, Geater A. Synchronized electrical stimulation in treating pharyngeal dysphagia [J]. Laryngo-scope, 2002, 112: 2204-2210.

(本文校对: 侯培红 收稿日期: 2012-06-14)